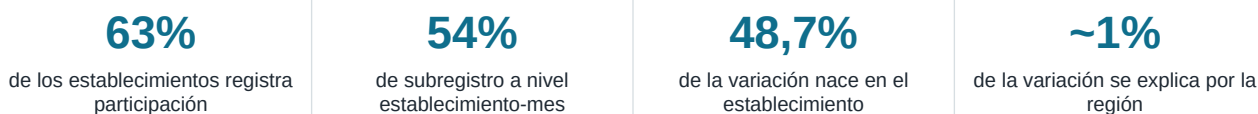


Participación ciudadana en salud: un fenómeno institucional, no territorial

140.507 registros · 2.982 establecimientos · REM 2025 (DEIS-MINSAL) · Javier Vera Bravo

MENSAJE CLAVE

Lo que determina que un establecimiento registre participación es el propio establecimiento y su gestión local, no la región ni la pobreza del territorio. Reducir el subregistro exige intervenir establecimientos y tipos concretos, no regiones tratadas como un todo.



El contexto

La participación ciudadana en salud es a la vez un derecho (Ley N.º 20.500) y un determinante social de la salud (CSDH/OMS). En Chile se registra cada mes en los REM, sección A19b, que consolida tres familias de actividad: atención de reclamos (OIRS), participación social (consejos, cabildos, diálogos) y satisfacción usuaria. Pese a su relevancia, el subregistro y la heterogeneidad entre establecimientos rara vez se analizan con métodos formales. Este trabajo lo hace con datos abiertos y modelos adecuados a la naturaleza del dato.

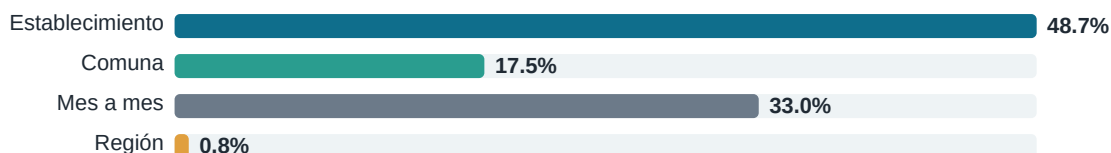
Qué muestran los datos

El registro es desigual y está subregistrado. El 63% de los establecimientos registró alguna participación en 2025, pero el 37% nunca lo hizo y más de la mitad de las combinaciones establecimiento-mes no tienen registro. El desafío central es la **sistematicidad** del registro, no la participación en sí.

El tipo de establecimiento manda. Los CESFAM y hospitales participan casi universalmente (~100%); los servicios de urgencia (SAPU 13%, SUR 2%) y las postas rurales (~60%) quedan muy por debajo. No es negligencia: en esos dispositivos las estructuras de participación no forman parte de su modelo de atención. Es una brecha **estructural**.

La geografía y la pobreza no explican la participación. Un modelo multinivel de tres niveles muestra que casi la mitad de la variación vive en el establecimiento y casi nada (~1%) en la región. La pobreza comunal no la predice de forma significativa y no hay clústeres territoriales (I de Moran no significativo).

¿Dónde se origina la variación en la participación?



Participación ciudadana en salud: un fenómeno institucional, no territorial

140.507 registros · 2.982 establecimientos · REM 2025 (DEIS-MINSAL) · Javier Vera Bravo

Qué implica para la política pública

1

Focalizar en establecimientos y tipos, no en regiones

Como la región explica ~1% de la variación, las metas de participación deben fijarse por tipo de establecimiento y por establecimiento individual. Priorizar el acompañamiento a servicios de urgencia y postas rurales, donde la participación no está incorporada al modelo de atención.

2

Tratar el subregistro como problema de gestión del dato

El 54% de subregistro establecimiento-mes sugiere que buena parte del 'no participa' es 'no registra'. Estandarizar el reporte de la sección A19b, capacitar a los referentes y dar retroalimentación mensual reduciría la brecha sin costo clínico.

3

Revisar la respuesta a reclamos donde el plazo legal se incumple

La calidad de respuesta a reclamos varía enormemente entre redes: Coquimbo (44%) y Valparaíso (33%) responden fuera del plazo legal con mucha más frecuencia que Magallanes (<1%). Es una brecha de capacidad de gestión, focalizable y medible.

4

Reconocer que 'participar' no es una sola cosa

Cuatro perfiles emergen de los datos: desde CESFAM urbanos centrados en reclamos (OIRS) hasta postas rurales centradas en participación social comunitaria. Las estrategias deben diferenciarse según el perfil, no aplicar una métrica única de volumen.

Cómo se obtuvo

Análisis reproducible en R sobre los REM 2025 del DEIS, cruzados con la base maestra de establecimientos y la estimación de pobreza comunal CASEN-SAE. Métodos elegidos por la naturaleza del dato: modelo de barrera (*hurdle*) para el exceso de ceros, modelo multinivel de tres niveles para la descomposición de varianza, autocorrelación espacial (I de Moran/LISA) y agrupamiento (k-means). Todo el código es abierto y el tablero se reconstruye automáticamente cada mes.

Limitaciones

Se mide el **registro** de participación, no la participación real: un cero puede ser ausencia de actividad o subregistro administrativo. El diseño es observacional (no causal) y cubre un año (2025). La pobreza comunal usa la estimación CASEN más reciente a nivel de comuna.

Dashboard interactivo en vivo: arleq89.github.io/participacion-salud-rem

Código y datos: github.com/Arleq89/participacion-salud-rem · Autor: Javier Vera Bravo (@Arleq89)